

CC Locomoteur

L'examen clinique doit suivre une hypothèse de l'anamnèse

Patient dit avoir mal à une articulation

- ➔ Caractériser la douleur pour voir si mécanique, inflammatoire, neuropathique ou ischémique
- ➔ Antalgie ?

Examen clinique

- **Inspection** : voir l'articulation comment elle est, voir comment le patient marche (si pb jambe) -> déformation, symétrie, masse musculaire, boiterie, rouge ?
- **Palpation** : on cherche douleur, on cherche épanchement, chaud ? froid ?, on palpe les repères anatomiques à côté
- **Examen fonctionnel** d'abord actif puis passif (pour qu'un patient nous laisse l'examiner en passif, il faut qu'il ait confiance donc on va lentement, on utilise les deux mains, on lui dit de bien poser le bras, etc)
 - Tendinite -> ça fait mal en actif mais pas en passif s'il se détend bien
 - Si en actif et en passif on a une diminution de l'amplitude articulaire, c'est probablement un problème de l'articulation même (ex ménisque qui bloque)
 - Si en passif c'est normal mais en actif il arrive pas -> soit tendon, muscle ou nerf fonctionnent pas
 - Pas passer 5min à mesurer les angles de toute la jambe
 - Ex : qq qui a une sciatique, pas d'intérêt à mesurer les angles
- Puis tests fonctionnels pour comprendre quelle structure exactement fait mal
- Pas hésiter à haute voix ce qu'on fait
- Bien garder le temps, s'il nous reste 2 minutes il vaut mieux stopper l'EC et asseoir le patient pour lui dire le diagnostic, lui expliquer, etc

Épaule

- Mal à l'épaule droite
- **Jobb** = sus-épineux
- **Lift-off** = sous-scapulaire
- Rotation externe = infra-épineux
- **Test d'appréhension** -> pour les patients qui ont eu une luxation de l'épaule (9/10 sont antérieures), épaule en abduction à 90 degrés, coude fléchi et patient essaie de faire une rotation interne
 - Médecin avec pouce essaie de luxer la tête de l'humérus et avec l'autre bras, lui tient le bras qui fait le mouvement (paume contre paume)
- Petit rond = rotation externe mais avec épaule en abduction à 90 degrés
- Conflit sous-acromial c'est global pour la coiffe des rotateurs (écharpe et on appuie sur le coude vers le bas)
- Si fait le mouvement mais douleur ++ -> tendinite
- Si arrive pas -> rupture des tendons, fracture, etc
- Pour tester articulation acromio-claviculaire -> écharpe et t'appuies sur le coude « dans l'axe »

Genou

Flexion et extension

Test du glaçon -> épanchement

Tiroirs antérieurs et postérieurs (doc assis sur le pied)-> ligaments croisés

Lachmann (comme tiroirs) mais genou à 30 degrés avec genou de l'examineur sous le genou du patient et on tient fémur avec une main et tibia avec l'autre et on test

Ligaments collatéral latéral interne/externe : genou fléchi à 30 degrés et on test en varus/valgus

Ménisques : poivrier sur le ventre et Mac Murray -> patient nous dit où il a mal, on peut utiliser varus/valgus pour mettre un peu plus de tension aussi

(<https://www.piriforme.fr/bdd/orthopedie/genou/mcmurray>)

Hanche

Flexion, extension, rotation interne et externe, abduction et adduction

Sacro-iliaques

- Patient debout, on met pouces sur épine iliaque antéro-supérieure (fin de la crête iliaque) et le patient se met sur une jambe et ça leur fera mal si sacro-iliite
- Patient couché sur le dos, on prend les 2 crêtes iliaques et on appuie dessus (fort, tout notre poids)
- Une jambe pend de la table, l'autre en flexion (genou et hanche) et on force la flexion de la jambe en gardant l'autre en extension max (on essaie de twister le bassin)
- Patient sur le ventre et on appuie sur les sacro-iliaques

Test de Faber (test du 4), on fixe l'épine iliaque antéro-sup controlatérale et on appuie sur le genou -> selon où est douleur, aide entre coxo-fémorale ou sacro-iliaque

Pour le goniomètre

1. Garder la moitié avec la flèche noire dans la main et c'est l'autre bout de plastique qui bouge
2. En position neutre, regarder où est le zéro et c'est pile à cet endroit qu'on lira l'autre chiffre après